

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Pediátrica —

PACIENTE

Emiliano Ortega Soto

DOCUMENTO

TI 1121000004

FECHA NACIMIENTO

08/11/2018

EDAD

7 años, 6 meses

SEXO

Masculino

ESCOLARIDAD

2° Primaria

LATERALIDAD

Diestro

FECHA DE EVALUACIÓN

07/06/2026

ORDEN N°

OM-2026-001237

PROTOCOLO APLICADO

WISC-IV + Vineland + SNAP-IV

ELABORADO POR

Profesional admin-read

Psicólogo

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Emiliano Ortega Soto	Lateralidad:	Diestro
Documento:	TI 1121000004	Ocupación:	Estudiante
Fecha de nacimiento:	08/11/2018	Ciudad:	Barranquilla, Atlántico
Edad:	7 años, 6 meses	Acompañante:	Marlene Soto de Ortega
Sexo:	Masculino	Remite:	Pediatra tratante
Escolaridad:	2° Primaria	EPS / Asegurador:	Nueva EPS

MOTIVO DE CONSULTA

Hiperactividad motora, impulsividad severa. No permanece sentado, interrumpe constantemente, accidentes frecuentes. Inicio en jardín, persiste en primaria.

HISTORIA DEL DESARROLLO

Hitos relevantes en la trayectoria evolutiva

Perinatales y prenatales

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

Trayectoria escolar

Estudios: 2° Primaria. Ocupación: Estudiante.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: WISC-IV + Vineland + SNAP-IV

Prueba	Dominio	Dur.
Diseño con Cubos	Razonamiento Perceptual	—
Semejanzas	Comprensión Verbal	—
Vocabulario	Comprensión Verbal	—
Claves	Velocidad de Proceso	—
Regresión Dígitos Directos	Memoria de Trabajo	—
Ind Comp Verb	Índice CI	—
Ind Raz Perce	Índice CI	—
Ind Mem Trab	Índice CI	—
Ind Vel Proce	Índice CI	—
CI total	Inteligencia General	—
Vineland	Funcionamiento Adaptativo	—

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Sin antecedentes psiquiátricos previos.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Niega TEC previo.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica completa. Paciente colaborador. Sin incidentes durante la aplicación.

Atención y concentración

Atención sostenida limitada (3-4 min). Errores de comisión en tareas de vigilancia. Omisiones por distracción.

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo global: F90.2 - TDAH tipo combinado

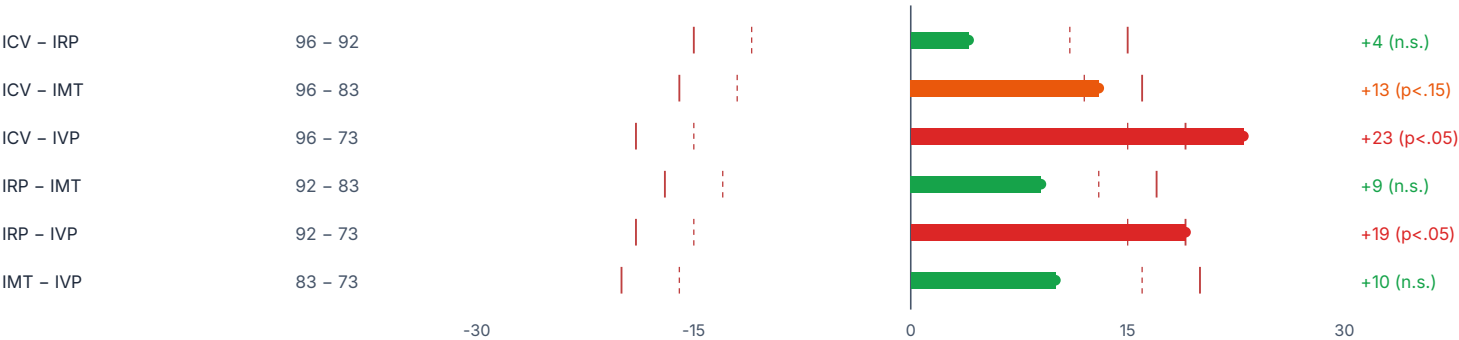
RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes estandarizados y perfil cognitivo

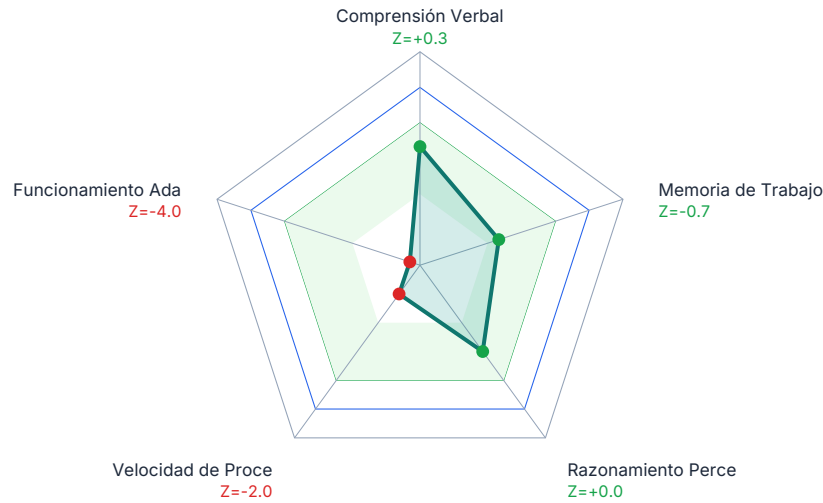


Discrepancias entre índices

Diferencia = valor del primer índice – segundo. Líneas críticas según Wechsler (p<.15 ... y p<.05).

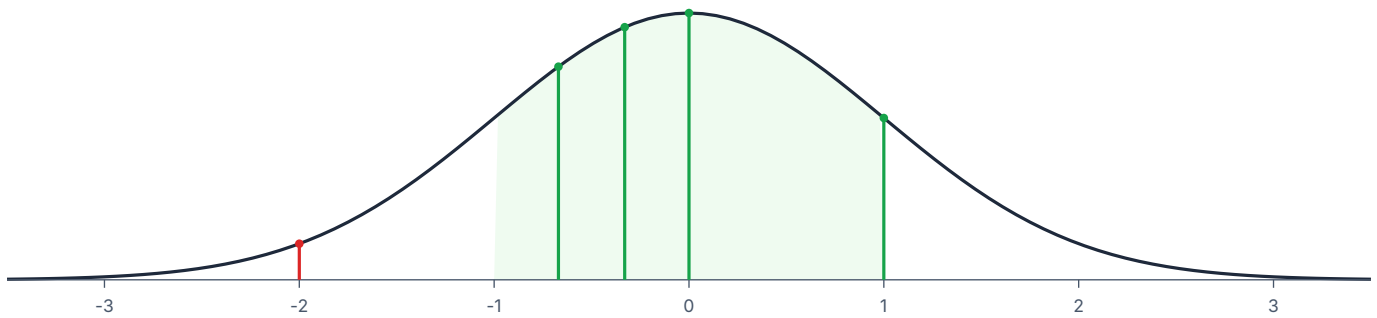


Perfil cognitivo por dominio



Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 6 pruebas con norma disponible



Perfil Z por prueba

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
Diseño con Cubos							+0.00
Semejanzas							+1.00
Vocabulario							-0.33
Claves							-2.00
Regresión Dígitos Directos							-0.67
Ind Comp Verb							-0.27
Ind Raz Perce							-0.53
Ind Mem Trab							-1.13
Ind Vel Proce							-1.80
CI total							-1.07
Vineland							-3.97

Banda verde = rango normal (-1 a +1 σ). Z<-1 sugiere debilidad. Z>+1 sugiere fortaleza relativa.

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
Diseño con Cubos	20	10	+0.00	Promedio
Semejanzas	18	13	+1.00	Superior
Vocabulario	20	9	-0.33	Promedio
Claves	22	4	-2.00	Bajo
Regresión Dígitos Directos	11	8	-0.67	Promedio
Ind Comp Verb	28	96	-0.27	Promedio
Ind Raz Perce	26	92	-0.53	Promedio
Ind Mem Trab	14	83	-1.13	Promedio
Ind Vel Proce	10	73	-1.80	Limítrofe
CI total	78	84	-1.07	Promedio
Vineland	78	10	-3.97	Bajo

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

Emiliano obtuvo un Cociente Intelectual Total (CIT) de 84, ubicándose en la categoría promedio bajo (percentil aproximado 14). Se observa una variabilidad relevante entre sus índices compuestos: el más bajo corresponde a IVP (73) y el más alto a ICV (96), lo que sugiere un perfil asimétrico que conviene analizar por separado más que resumir en una única puntuación global.

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: funcionamiento adaptativo (severamente disminuido, $Z=-4.0$); velocidad de proceso (severamente disminuido, $Z=-2.0$).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran Vineland ($Z=-3.97$, bajo); Claves ($Z=-2.00$, bajo). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño preservado / superior

- Vineland — bajo ($Z=-3.97$)
- Claves — bajo ($Z=-2.00$)
- Semejanzas — superior ($Z=+1.00$)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Emiliano. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En NiWiscDC, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En NiWiscSem, tu rendimiento fue muy por encima del promedio. En NiWiscVoc, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En NiWiscCI, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo. En NiVin, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

Áreas para apoyar (en qué trabajar)

- En NiWiscDC, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiWiscSem, tu rendimiento fue muy por encima del promedio.
- En NiWiscVoc, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiWiscRDD, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiWISCIndComVer, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiWiscCI, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.
- En NiVin, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

¿Qué recomendamos?

Sobre la terapia: continúa con tus sesiones según lo acordado. Si tienes dudas, coméntalas con tu terapeuta.

Preguntas frecuentes

• ¿Mis resultados son permanentes?

No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica y los apoyos adecuados. Los resultados que obtuviste son una foto del momento actual.

• ¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?

Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto no significa que haya algo mal en ti.

• ¿Necesito otro tipo de evaluaciones?

Tu psicólogo/a te dirá si se necesitan otros estudios (por ejemplo, evaluación pedagógica, médica, o del lenguaje). No te preocupes si no entiendes algún término: puedes preguntar siempre.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: F90

Impresión diagnóstica: F90.2 - TDAH tipo combinado

RECOMENDACIONES

Plan de manejo agrupado por área y prioridad

- Se recomienda seguimiento clínico y plan terapéutico según hallazgos. Reevaluación en 6-12 meses si aplica.

ANEXO — DEFINICIONES OPERATIVAS

Convenciones interpretativas utilizadas en este informe

Cociente Intelectual (CI)

Puntuación estándar con media 100 y desviación 15. CIT menor a 70 sugiere déficit; 70-79 límite; 80-89 promedio bajo; 90-109 promedio; 110-119 promedio alto; 120-129 superior; ≥ 130 muy superior.

Puntaje escalar (PE)

Subtests Wechsler — media 10, desviación 3. PE de 8-12 equivale al rango promedio.

Puntuación Z

Desvío en unidades de desviación estándar respecto al grupo normativo. $Z = (PD - \mu) / \sigma$. $Z \leq -1$ indica rendimiento bajo el promedio; $Z \leq -2$ indica déficit clínico.

Percentil

Porcentaje de la población normativa con desempeño igual o inferior al del paciente.

Discrepancia significativa

Diferencia entre índices que excede el umbral de Wechsler. Líneas críticas: $p < .15$ (.....) sugieren tendencia; $p < .05$ () indican diferencia confiable.

Reliable Change Index (RCI)

Jacobson-Truax. $RCI > 1.96$ indica cambio confiable ($p < .05$) entre evaluaciones repetidas. Se reporta sólo en informes de seguimiento.